	FORMATO PLANTILLA DE ACTA	**CÓDIGO:**
	HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRÁ E.S.E.	GC-C-F-003
	PROCESO: CALIDAD	**VERSIÓN:**
	SUBPROCESO: CONTROL DE PRODUCCIÓN DOCUMENTAL	V02-2025

Planeación

Fecha

Miércoles, 25 de Febrero de 2026 / 06:02 PM - 07:00 PM

Lugar

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA - PISO GINECOLOGIA

Asistentes

Nombre	Cargo	Área/Empresa
Ximena Paola Vela Vargas	MEDICO GENERAL	Unidades Funcionales
Luisa Fernanda Pardo Diaz	PROFESIONAL DE ENFERMERIA - COORD. GINECO-OBSTETRICIA	Unidades Funcionales
Sharon Katherine Acuña Rubiano	LÍDER DE GINECOOBSTETRICIA	Hospitalización
Katherin Yuliana Camargo Zambrano	MEDICO ESPECIALISTA-GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	Unidades Funcionales
Karen Mayeissy Gomez Gomez	AUXILIAR DE ENFERMERIA	Unidades Funcionales
Leidy Alexandra Gandur Dorias	AUXILIAR DEL ÁREA DE LA SALUD	Unidades Funcionales
Jennyfer Milena Sarmiento Mantilla	PROFESIONAL DE ENFERMERIA	Unidades Funcionales

Tema de Reunión / Equipo Primario

SIMULACRO TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO - ESTRATEGIA ISABEL

Desarrollo

Contenido

ORDEN DEL DÍA

SE REALIZA SIMULACRO DE TRASTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO APLICANDO ESTRETEGIA ISABEL EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

SE REALIZA UN SIMULACRO DE TRANSTORNOS HIPERTENSIVOS DEL EMBARAZO EN EL SERVICIO DE GINECOLOGIA PARA EL MES DE FEBRERO CON EL SIGUIENTE CASO

-

Paciente Luisa pardo, ubicada en ginecologia primigestante con embarazo de 38 semanas quien ingresa con signos vitales al TRIAGE y en control en ginecologia con TA en 150/115 fc 63 fr 18 t 36.1 sat 93 % fcf 142

Vista Previa

El equipo de ginecologia en cabeza de la medico del servicio Dra vela realiza activación de equipo de respuesta rápida , se verifica por medio del video como se activa estrategia institucional I. D. E.A.S y se inicia el manejo (ver VIDEO soporte)

Al evaluar las acciones se evidencian las siguientes acciones correctas.

- Se diligencia formato IDEAS institucional y se activa equipo de WhatsApp de activación de equipo de respuesta rápida obstétrica.
- Se realiza manejo con Sulfato de magnesio iv y dosis según estrategia ISABEL
- Se coloca Doble acceso venoso y Sonda vesical
- Monitora continua toma de signos vitales cada. 5 minutos para seguimiento de tensión arterial
- Se verifica. Comunicación en asa cerrada
- Se diligencia lista de chequeo estrategia ISABEL
- Asiste laboratorio a toma de paraclinicios de manera inmediata
- Se decide finalizar la gestación , no específican la vida
- Se solicita laboratorios ,salas de cirugía y unidad e cuidados intensivos.

ACCIONES INCORRECTAS.

- Se clasifica en estrategia IDEAS como triaje 2 cuando es TRIAGE 1 por crisis
- Se indica un bolo de liquidos que no cumple con lista de chequeo para manejo según estrategia ISABEL
- Inicialmente se clasifica como triaje 2 por TA en 150 /100 , siembargo en la activación en el diligenciamiento de estrategia IDEAS se clasifica como TRIAGE 2 a pesar de cifras tensiones en CRISIS que da un TRIAGE 1.
- Se realiza manejo de primera linea con nifedipino no se especifica la dosis y se inicia con 30 mg
- No se evidencia administración de labetalol el cual es primera Linea
- No contesta salas de cirugía el grupo de activación
- No especifican vía de finalización de la gestación

Planes de mejora

- Realizar una ayuda visual para los médicos con el manejo farmacológico de la CRISIS HIPERTENSIVA para consulta rápida
- Realizar una plantilla para diligenciar con las ordenes de manejo de CRISIS HIPERTENSIVA
- Desde enfermería realizar un análisis de todos los casos desde protocólo de Londres de activación de equipos de respuesta rápida obstétrica

Compromisos

- Realizar una ayuda visual para los médicos con el manejo farmacológico de la CRISIS HIPERTENSIVA para consulta rápida

Realizar una ayuda visual para los médicos con el manejo farmacológico de la CRISIS HIPERTENSIVA para consulta rápida

Responsables: Caren Natalia Bohorquez, Ximena Paola Vela Vargas

Fecha límite: 2026-02-25

- Realizar una plantilla para diligenciar con las ordenes de manejo de CRISIS HIPERTENSIVA

Realizar una plantilla para diligenciar con las ordenes de manejo de CRISIS HIPERTENSIVA

Responsables: Ximena Paola Vela Vargas

Fecha límite: 2026-02-25

- Desde enfermería realizar un análisis de todos los casos desde protocólo de Londres de activación

Vista Previa

de equipos de respuesta rápida obstétrica

Desde enfermería realizar un análisis de todos los casos desde protocólo de Londres de activación de equipos de respuesta rápida obstétrica

Responsables: Luisa Fernanda Pardo Diaz

Fecha límite: 2026-02-25

Vista Previa